

CAPÍTULO 13.63

Manejo de la Rinitis Alergica

PERFIL EUNACOM 1.13.63

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Prick Test**, también conocido como test de punctura cutánea, es la herramienta diagnóstica de elección para identificar la **sensibilización mediada por IgE** frente a diversos alérgenos. Es una prueba fundamental en el estudio de patologías como la **Rinitis Alérgica**, el **Asma** bronquial y las alergias alimentarias.

¿Qué evalúa el Prick Test?

Su objetivo principal es demostrar la presencia de **sensibilización**. Es fundamental entender que una prueba positiva no equivale automáticamente a una alergia clínica; la interpretación siempre debe realizarse en el contexto de la historia del paciente.

- Se utiliza para testear diferentes categorías de alérgenos:
- Alérgenos respiratorios (Aeroalérgenos):** Ácaros del polvo, pólenes (gramíneas, malezas, árboles), epitelios de animales (perro, gato) y hongos.
- Alérgenos alimentarios:** Leche de vaca, huevo, frutos secos, pescados, mariscos, legumbres, entre otros.
- Alérgenos de exposición laboral:** Látex, harinas, enzimas industriales.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: El Prick Test reproduce a pequeña escala una reacción de hipersensibilidad tipo I (inmediata). Al introducir el alérgeno en la epidermis, este interactúa con la IgE específica unida a la superficie de los **mastocitos** cutáneos. Si hay sensibilización, el mastocito se degranula liberando histamina y otros mediadores que provocan vasodilatación y edema local (la "roncha").

Técnica del Procedimiento

El procedimiento es mínimamente invasivo y se realiza generalmente en la cara anterior del antebrazo.

- Limpieza:** Se limpia la piel con alcohol o agua.
- Marcación:** Se marcan los puntos donde se aplicarán las gotas de los extractos alérgenos, dejando una separación de al menos 2 cm entre cada uno para evitar la coalescencia de reacciones.
- Aplicación de gotas:** Se coloca una gota de cada extracto, incluyendo siempre los controles.
- Puntura (Lanceta):** Con una lanceta estéril o aguja fina, se realiza una mínima escoriación epidérmica a través de la gota. Es crucial **no producir sangrado** y cambiar el dispositivo (o limpiar meticulosamente) entre cada alérgeno para evitar la contaminación cruzada.
- Espera:** Se deja actuar por un periodo de **15 a 20 minutos**.
- Lectura:** Se mide el diámetro de la pápula (roncha) resultante.

Interpretación de los Resultados

Para que la prueba sea válida, los controles deben funcionar correctamente.

Criterio de Positividad

Se considera que un paciente está **sensibilizado** a un alérgeno si: - El control positivo es adecuado. - El control negativo es negativo. - El alérgeno produce una **roncha con un diámetro mayor o igual a 3 milímetros**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: El Prick Test detecta **sensibilización**, no necesariamente enfermedad. El diagnóstico de "Alergia" es **clínico**. Si el test es positivo pero el paciente no presenta síntomas al exponerse al alérgeno, se dice que está sensibilizado pero no es alérgico.

Limitaciones y Consideraciones

Existen factores que pueden alterar el resultado, llevando a falsos negativos o situaciones de riesgo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Interferencia Farmacológica: Los **antihistamínicos** (H1) deben suspenderse al menos 3 a 7 días antes de la prueba, ya que bloquean la respuesta de la histamina y pueden dar falsos negativos. Otros fármacos como antidepresivos tricíclicos también pueden interferir.

- Edad:** En lactantes muy pequeños o ancianos, la reactividad cutánea puede estar disminuida.
- Estado de la piel:** No se debe realizar en zonas con eccema activo, dermatografismo severo o quemaduras solares.
- Riesgo de Anafilaxia:** Aunque es extremadamente raro con la técnica de prick (a diferencia de las pruebas intradérmicas), siempre debe realizarse en un entorno médico que cuente con equipo de reanimación y adrenalina disponible.

Resumen de Utilidad Clínica

- **Asma y Rinitis Alérgica:** Identifica los gatillantes ambientales para guiar medidas de control ambiental y evaluar la posibilidad de inmunoterapia (vacunas de alergia). - **Alergia Alimentaria:** Ayuda a identificar el alimento sospechoso, aunque a menudo requiere confirmación con pruebas de provocación oral si la clínica es dudosa. - **Seguimiento:** Permite evaluar si un paciente ha desarrollado tolerancia espontánea (común en alergias alimentarias infantiles).

NOTA CLÍNICA

Si un paciente tiene una historia clínica muy sugerente de alergia pero el Prick Test es negativo, se puede solicitar una **IgE específica en sangre** (ImmunoCAP) para complementar el estudio.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de 25 años con rinitis alérgica diagnosticada clínicamente presenta obstrucción nasal severa como síntoma predominante, además de rinorrea acuosa y estornudos frecuentes. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Manejo de la Rinitis Alérgica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

TABLA 13.63.1: ELEMENTO VS SUSTANCIA

ELEMENTO	SUSTANCIA	RESULTADO ESPERADO	UTILIDAD
Control Positivo	Histamina (10 mg/ml)	Roncha $\geq$ 3 mm	Confirma que la piel es reactiva y que no hay fármacos interfiriendo.
Control Negativo	Suero Fisiológico	Roncha de 0 mm	Asegura que el paciente no presenta dermatografismo (reacción por el roce).
Alérgenos	Extractos específicos	Variable	Evalúa la sensibilización específica.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El diagnostico de rinitis alergica es clinico; el prick test identifica alergenos y descarta alergía en rinitis no alergica
- Antihistaminicos de segunda generacion: loratadina, desloratadina, cetirizina, levocetirizina, fexofenadina (anti-H1, no confundir con anti-H2)
- Corticoides topicos nasales: fluticasona, mometasona, budesonida; son mas eficaces que los antihistaminicos
- Corticoides topicos son de eleccion en rinitis grave y cuando predomina la obstruccion nasal
- Se puede iniciar con antihistaminicos o corticoides y agregar el otro si no hay respuesta
- Corticoides orales (prednisona) solo en casos refractarios graves o con polipos nasales
- Los polipos nasales impiden la llegada del corticoide topico, requiriendo inicio con corticoide oral

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DE LA RINITIS ALERGICA)**PREGUNTA 1**

Un paciente de 25 años con rinitis alergica diagnosticada clinicamente presenta obstruccion nasal severa como sintoma predominante, ademas de rinorrea acuosa y estornudos frecuentes. ¿Cual es el tratamiento farmacologico de primera linea mas adecuado?

- A)** Antihistaminicos de primera generacion (clorfenamina)
- B)** Antihistaminicos de segunda generacion (loratadina)
- C)** Corticoide topico nasal (fluticasona)
- D)** Corticoides orales (prednisona)
- E)** Descongestionante topico (oximetazolina)

PREGUNTA 2

¿En cual de las siguientes situaciones esta indicado iniciar corticoides ORALES en una rinitis alergica?

- A)** Rinitis alergica estacional leve de reciente diagnostico
- B)** Rinitis alergica con prurito nasal como sintoma predominante
- C)** Rinitis alergica grave asociada a polipos nasales que no responde a tratamiento topico
- D)** Rinitis alergica perenne en un paciente que prefiere medicacion oral
- E)** Rinitis alergica en paciente con asma leve intermitente

PREGUNTA 3

Un medico general indica ranitidina a un paciente con rinitis alergica. ¿Cual es el error en esta indicacion?

- A)** La ranitidina es un anti-H2, no un anti-H1; no tiene efecto sobre la alergía
- B)** La ranitidina es un antihistaminico de primera generacion y causa mucha somnolencia
- C)** La ranitidina esta contraindicada en pacientes alergicos
- D)** La ranitidina solo funciona por via endovenosa, no oral
- E)** La ranitidina es un corticoide, no un antihistaminico

RESUMEN: MANEJO DE LA RINITIS ALERGICA

Esta clase aborda el manejo farmacológico de la rinitis alérgica. El diagnóstico es absolutamente clínico, sin necesidad de exámenes. El prick test tiene dos utilidades: identificar el alérgeno específico (para medidas de evitación) y descartar causa alérgica cuando la clínica sugiere rinitis no alérgica, ya que las rinitis no alérgicas son un diagnóstico de descarte que requiere prick test negativo. El tratamiento farmacológico se basa en dos pilares: antihistamínicos de segunda generación (loratadina, desloratadina, cetirizina, levocetirizina, fexofenadina) y corticoides tópicos nasales (fluticasona, mometasona, budesonida). Es fundamental no confundir los anti-H1 (antihistamínicos para alergia) con los anti-H2 (ranitidina, famotidina, para reflujo). Los antihistamínicos de segunda generación se administran una vez al día y son económicos. Los corticoides tópicos son más eficaces que los antihistamínicos y son de elección en dos situaciones: rinitis alérgica grave con muchos síntomas y cuando predomina la obstrucción nasal (los corticoides tienen mayor efecto sobre la obstrucción). Se puede iniciar con cualquiera de los dos fármacos y agregar el otro si no hay respuesta adecuada. Los corticoides orales (prednisona) se reservan para casos refractarios graves o cuando hay pólipos nasales, ya que los pólipos impiden el paso del corticoide tópico.